

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074279-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: AUREA ROMAO SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO À SAÚDE. MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TDAH E TRANSTORNO DE ANSIEDADE. LISDEXANFETAMINA E CANABIDIOL. USO OFF LABEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5074279-57.2024.4.02.5101

510014753428 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074279-57.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: AUREA ROMAO SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo Substituto da 1ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem] que indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual pretendia a demandante o fornecimento do medicamento **LISDEXANFETAMINA** e do fitofármaco **CANABIDIOL PRATI DONADUZZI (20MG/ML)**, de acordo com a prescrição médica e no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), destinados ao tratamento do quadro clínico de TDAH (CID 10: F90) e Transtorno de Ansiedade (CID 10: F41).

Pretende a reforma da decisão e a concessão da tutela porquanto estariam presentes os requisitos dispostos no art. 300 e seguintes do CPC. *In casu*, a probabilidade do direito estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova: a existência da patologia, a indispensabilidade das medicações ora pleiteadas, bem como a demora do Poder Público em prestar o devido atendimento. Já o risco ao resultado útil do processo seria evidente, eis que sem o tratamento adequado para a patologia, a requerente poderá sofrer sérias complicações de saúde, agravando seu quadro clínico, de maneira que o decurso do tempo pode causar efeitos irreversíveis.

Indeferimento da tutela recursal [evento 13, DESPADEC1].

Parecer do NAT-Jus [evento 25, PARECER1].

Sem contrarrazões pelas rés, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de dispensação, pelo Poder Público, de medicamentos sem indicação em bula para o tratamento do quadro clínico narrado (uso *off label*) e sem previsão em lista de dispensação pelo SUS. Em caso positivo, verificar se a parte autora demonstra o preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento gratuito, na forma do Tema 106 do STJ, em recursos repetitivos.

Consoante narrado em relatório, a demandante, ora recorrente, possui diagnóstico de TDAH (CID 10: F90) e Transtorno de Ansiedade (CID 10: F41), com recomendação de uso dos medicamentos **LISDEXANFETAMINA** e **CANABIDIOL PRATI DONADUZZI (20MG/ML)**, ante o risco de grave comprometimento do bem-estar, conforme laudo médico anexo aos autos de origem [evento 1, ANEXO2, fls. 14/18, dos autos de origem].

Quanto ao medicamento **Lisdexanfetamina**, o parecer técnico do NAT-Jus informa que possui registro ativo na ANVISA e está indicado para o tratamento do quadro clínico da recorrente, especificamente o TDAH. Todavia, não consta em nenhuma lista de dispensação pelo SUS, com destaque para o fato de que nenhum medicamento é fornecido para tratamento de TDAH, porquanto o CONITEC recomenda terapia cognitiva comportamental (TCC).

Já o **Canabidiol 20mg/mL**, há registro ativo na ANVISA, mas as evidências científicas de seu uso no tratamento do quadro clínico da demandante/recorrente ainda são baixas ou inconclusivas. Ademais, não consta da lista de dispensação pelo SUS.

Destaco os seguintes trechos do parecer do NAT-Jus:

*"Neste sentido, cumpre informar que o medicamento pleiteado Dimesilato de **Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse®)** possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e está indicado em bula1 para o manejo do quadro clínico apresentado pela Autora - transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conforme relato médico.*

*No que se refere ao produto pleiteado, informa-se que dentre os produtos a base de Canabidiol registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), **consta registro de Canabidiol 20mg/mL2**.*

(...)

*No que tange à disponibilização pelo SUS dos itens pleiteados, insta mencionar que **Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg (Venvanse®)** e **Canabidiol 20mg/mL** não integram nenhuma lista oficial de medicamentos/produtos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) para dispensação no SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.*

(...)

*Considerando todo o exposto acima, conclui-se que **são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico da Autora.***

(...)

*Para o tratamento de pacientes com TDAH o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade6, através da Portaria Conjunta Nº 14, de 29 de julho de 2022. **O uso da Lisdexanfetamina para tratamento de adultos com TDAH foi avaliado pela CONITEC, conforme a metodologia preconizada para incorporação de tecnologias no âmbito do SUS. As avaliações receberam recomendação contrária à incorporação pela Conitec. Assim, o uso deste medicamento não é preconizado neste Protocolo. O PCDT do TDAH preconiza tratamentos não medicamentosos, com destaque para a terapia cognitiva comportamental (TCC), e não prevê tratamento medicamentoso. Assim, o SUS não oferta medicamentos para tratamento do TDAH.***

Não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

As políticas públicas na área de saúde não incluem, via de regra, a dispensação gratuita de medicamentos para uso *off label*, ante expressa vedação do art. 19-T, I, da Lei 8.080/90:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (...) **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)**

A vedação não é absoluta, sendo excepcionalmente admitida quando houver **autorização do uso alternativo pela ANVISA**, na forma do art. 21 do Decreto nº 8.077/2013:

Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, desde que demonstradas pela Conitec as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido na solicitação.

A possibilidade excepcional de fornecimento de fármaco para utilização *off label* foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça:

O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da ANVISA.

STJ. 1ª Seção. PUIL 2.101-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/11/2021

Não suficiente, com a edição da Lei nº 14.313/2022 foi inserida expressa previsão no art. 19-T, parágrafo único, I, autorizando o fornecimento de medicamento para uso *off label*, desde que registrado na ANVISA e haja recomendação médica:

Art. 19-T. (...)

*Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)***

*I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde; **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)***

Verificada a excepcional possibilidade de uso alternativo ou *off label*, resta analisar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos elencados no Tema 106 (REsp nº 1.657.156), em recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Na espécie, entendo que não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pretendidos, assim como a ineficácia de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

Destaco que o laudo médico anexo à inicial nos autos de origem é vago quanto à utilização das alternativas terapêuticas, sem indicar quais foram os medicamentos administrados, restringindo-se a citar que a paciente apresentou "efeitos colaterais", sem especificá-los.

Ademais, apesar de classificada a demanda como urgente, o laudo é explícito ao suscitar risco de comprometimento do bem-estar da recorrente, mas sem qualquer possibilidade de dano irreversível.

Logo, **não há nos autos comprovação de iminente risco de dano irreversível** que justifique o fornecimento de medicamento *off label* em tutela de urgência.

Merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

